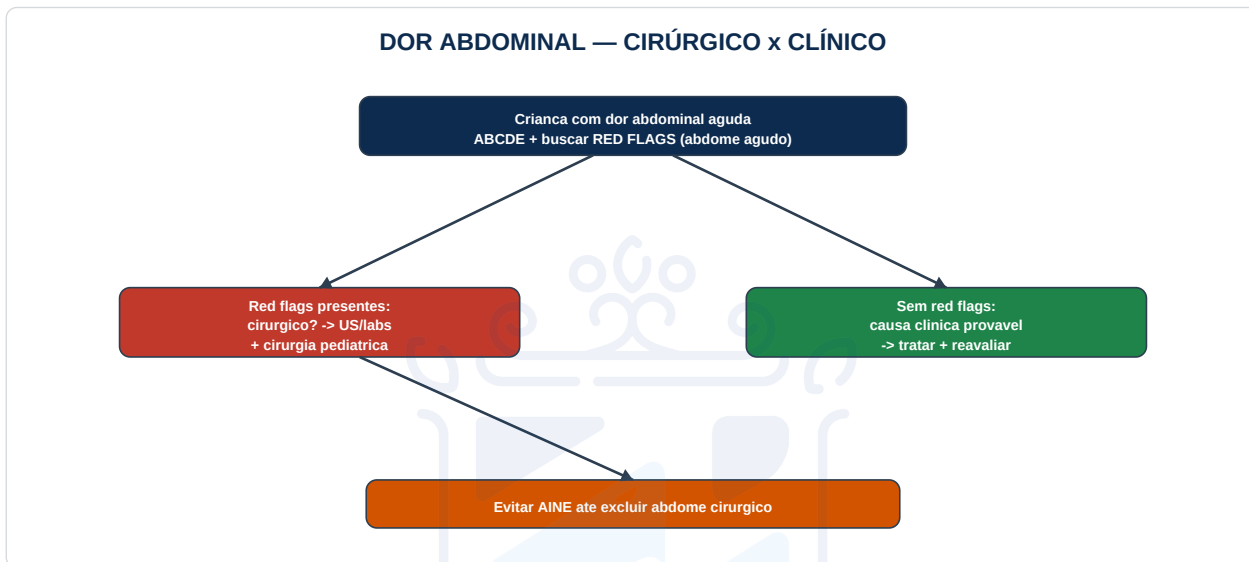


DOR ABDOMINAL NA CRIANÇA — EXCLUIR CIRÚRGICO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



CAUSAS POR FAIXA / SISTEMA

Grupo	Causas a considerar
Cirúrgico	Apendicite, invaginação intestinal (lactente, 'geleia de morango'), hérnia encarcerada, torção testicular/ovariana, obstrução, abdome agudo
Gastrointestinal	GECA, constipação, adenite mesentérica, ITU/pielonefrite, hepatite, gastrite
Urinário/genital	ITU, litíase, torção de testículo/ovário, doença inflamatória pélvica (adolescente)
Extra-abdominal	Pneumonia de base, CAD (cetoacidose diabética), PHS (púrpura de Henoch-Schönlein), faringite estreptocócica

RED FLAGS — ABDOME AGUDO

SINAIS DE ALARME

- VÔMITOS BILIOSOS (verdes) — obstrução até prova em contrário
- Sangue nas fezes ou nos vômitos; fezes em 'geleia de morango' (invaginação)
- Dor intensa, descompressão dolorosa, rigidez/defesa abdominal, distensão importante
- Dor testicular/escrotal aguda (torção — urgência cirúrgica de horas!)
- Toxemia, palidez, prostração, instabilidade hemodinâmica; dor que migra para FID (apendicite)

AValiação e Exames

NO PS

- Anamnese: localização, irradiação, tempo, febre, vômitos (biliosos?), hábito intestinal, sintomas urinários, alimentação, trauma; em meninas adolescentes: história menstrual/sexual
- Exame: abdome (massa, defesa, descompressão), genitália/bolsa escrotal SEMPRE, sinais respiratórios (excluir pneumonia)
- Exames conforme suspeita: hemograma, PCR, urina I/urocultura, amilase/lipase, transaminases, beta-hCG (adolescente)
- Glicemia/cetonemia se suspeita de CAD; gasometria se toxemia
- Imagem: US abdominal/pélvica e de bolsa escrotal (1a linha); RX se suspeita de obstrução/perfuração; TC em casos selecionados

TRATAMENTO SINTOMÁTICO

Rx ANALGESIA E ANTIEMÉTICO

Analgesia NÃO mascara nem atrasa o diagnóstico — deve ser oferecida: Dipirona 10-15 mg/kg/dose VO/EV
Paracetamol 10-15 mg/kg/dose como alternativa
Ondansetrona 0,15 mg/kg/dose se vômitos
EVITAR AINE (ibuprofeno) até excluir abdome cirúrgico/sangramento
Hidratação conforme estado; jejum se suspeita cirúrgica
NÃO usar antiespasmódicos/analgesia que dificulte a reavaliação seriada

CONDUTA / DISPOSIÇÃO

DECISÃO

- ☐ Suspeita cirúrgica (apendicite, invaginação, torção, obstrução): jejum, acesso venoso, avaliação da CIRURGIA PEDIÁTRICA, imagem
- ☐ INTERNAR/observar: dor persistente sem diagnóstico, red flags, vômitos biliosos, abdome em investigação
- ☐ ALTA: causa clínica benigna definida (constipação, GECA, ITU tratável ambulatorial), dor controlada, criança ativa, hidratada
- ☐ Reavaliação seriada do abdome é a melhor ferramenta no quadro indeterminado
- ☐ Retorno IMEDIATO: vômitos biliosos, sangue nas fezes, dor escrotal, piora da dor, febre alta, prostração

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/____ kg com dor abdominal há ____; localização ____; vômitos ____ (biliosos?); febre ____.
- Exame: defesa/descompressão ____, massa ____, bolsa escrotal ____; suspeita: ____ (apendicite/invaginação/torção).
- Exames: hemograma ____, US ____; jejum + acesso + analgesia.
- Solicito avaliação da cirurgia pediátrica / transferência para serviço com cirurgia pediátrica e US.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Lactente de 8 meses com dor abdominal em cólica, choro intermitente, vômitos e fezes em 'geleia de morango'. Diagnóstico mais provável?

- A) Constipação funcional
- B) Invaginação intestinal
- C) Gastroenterite viral
- D) Refluxo gastroesofágico
- E) Cólica do lactente

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual sinal é considerado red flag de obstrução intestinal na criança?

- A) Vômitos alimentares isolados
- B) Vômitos biliosos (esverdeados)
- C) Dor periumbilical leve
- D) Febre baixa
- E) Diarreia aquosa

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Menino de 13 anos com dor escrotal aguda e intensa, de início súbito. Qual a conduta prioritária?

- A) Antibiótico oral e reavaliação em 48h
- B) Avaliação urgente para torção testicular (urgência cirúrgica de horas)
- C) Analgésico e alta
- D) Apenas ultrassom eletivo
- E) Anti-inflamatório e repouso domiciliar

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a analgesia na dor abdominal aguda da criança em investigação, é correto:

- A) Deve ser evitada para não mascarar o diagnóstico
- B) Deve ser oferecida (não atrasa o diagnóstico), evitando AINE até excluir abdome cirúrgico
- C) Sempre usar AINE como primeira escolha
- D) Usar opioide de rotina em todos
- E) Analgesia só após a cirurgia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual causa EXTRA-abdominal pode se manifestar como dor abdominal na criança?

- A) Apendicite
- B) Pneumonia de base e cetoacidose diabética
- C) Invaginação intestinal
- D) Constipação
- E) Adenite mesentérica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Lactente com dor em cólica intermitente, vômitos e fezes em 'geleia de morango' (sangue + muco) é o quadro clássico da invaginação intestinal — emergência; US confirma ('sinal do alvo') e o enema pode ser terapêutico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Vômitos biliosos (esverdeados) indicam obstrução intestinal até prova em contrário e exigem investigação urgente (jejum, imagem, cirurgia pediátrica).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Dor escrotal aguda e súbita no adolescente é torção testicular até prova em contrário — urgência cirúrgica com janela de poucas horas para salvar a gônada. Exame da bolsa escrotal é mandatório em toda dor abdominal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A analgesia adequada deve ser oferecida e não atrasa nem mascara o diagnóstico; evita-se o AINE até excluir abdome cirúrgico/sangramento. A reavaliação seriada é a melhor ferramenta no quadro indeterminado.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Causas extra-abdominais como pneumonia de base e cetoacidose diabética podem se manifestar como dor abdominal — por isso o exame respiratório e a glicemia/cetonemia fazem parte da avaliação.

SM24
Suporte ao Plantão Médico